

Fecha Última Actualización: 23-09-2022 18:11:51

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Silvia Ester Andrade Tobar
Edad : 58a 4m 30d
Dirección : Valdivia 0416 Pobl San Gregorio

Rut : 12.019.943-9
Fecha Nacto: 24/04/1964
Comuna : La Granja

N° Archivo : 9839733
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4785 2662

N° Epicrisis
323799

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Ingreso : 01/08/2022 03:23

Días Estadía: 53

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 23/09/2022 16:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Ventriculostomía O Instalación De Derivativa Ventricular Externa O Instalación De Captor Para Medición De Pic O Punción Biopsia O Reservorio Para Administración De Medicamentos - 01/08/2022 03:55 - Victoria Oliva Zuñiga
Angiografía Cerebral Digital Por Cateterización (Incluye Proc. Radiológico, Medio De Contraste E Insumos) - 04/08/2022 13:30 - Juan Carlos Zamora Joglar
Ventriculostomía O Instalación De Derivativa Ventricular Externa O Instalación De Captor Para Medición De Pic O Punción Biopsia O Reservorio Para Administración De Medicamentos - 20/08/2022 17:50 - Eduardo Alejandro Ramirez Welsch
Instalación De Derivativas De Lcr (Incluye Valor De La Válvula) - 09/09/2022 15:10 - Eduardo Alejandro Ramirez Welsch

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 01/08/2022
FI UCI: 05/08/2022
FI UTIN: 25/08/2022
FI Neurología agudos: 13/09/202

Paciente diestra, mRS 0, con lo siguientes antecedentes:

- Mórbidos (-)
- Medicamentos (-)
- Alergias (-)
- Cirugía: Ooforectomía unilateral
- Social: vive en La Granja, con familia. Escolaridad 6to básico.

Historia:

Derivada desde APS a HPH y trasladada posteriormente a CASR por cuadro de cefalea de inicio súbito (aparentemente no ictal) en la mañana del 31/07. En APS se describió hipertensa, con focalidad neurológica consistente en desviación de comisura labial a izquierda y hemiparesia braquiocrural izquierda. En HPH ingresó en malas condiciones generales, somnolienta, hipertensa, GCS 14 y parética M3 braquiocrural izquierda. Se realizó AngioTC Cerebro (31/07 a las 16 hrs) que mostró extensa hemorragia intraventricular con hidrocefalia asociada, además se describieron vasos "arrozariados" a nivel de polígono de Willis, sin clara evidencia de etiología de este. Se intubó previo a traslado a CASR, ingresando a las 2 am del 01/08 al reanimador del servicio de urgencias. Se describió abundante vómito en camilla y cavidad oral a su llegada, por lo que se aspiró e instaló SNG, con sospecha de aspiración. A su ingreso, paciente, hipertensa (PA 163/97 mmHg), bradicárdica (FC 58 lpm) se describió en GCS 3/15 que mejoró hasta 7/15 tras suspender sedación, con pupilas mióticas isocóricas, reflejo corneal (-) y M1 mano derecha, por lo que se trasladó a pabellón urgencias para instalación de DVE. Se realizó procedimiento

Fecha Epicrisis : 23/09/2022 18:11

Página 1 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 23-09-2022 18:11:51

Página 2 de 5

sin mayores incidentes, saliendo a recuperación. Permaneció en recuperación de anestesia, donde se inició tratamiento antibiótico con ampicilina/sulbactam dado neumonía aspirativa. DVE con persistente débito hemorrágico, se realizó angiografía diagnóstica al 4to día de estancia hospitalaria. Protocolo operatorio se describe:

"oclusión de la terminación de la arteria carótida interna con desarrollo de múltiples vasos de moyamoya que irrigan el territorio profundo y se anastomosan con arteria cerebral media y cerebral anterior derechas. Anastomosis de vasos de arteria meníngea media con ramas corticales de ACA y ACM derechas. A izquierda se observa oclusión distal de ACI, con desarrollo de vasos de moyamoya que anastomosan con ACM y ACA. Arteria trigeminal persistente. Colaterales desde ACP a territorios de ACM ipsilateral. Drenaje venoso cerebral en rangos"

Se mantuvo con medidas de neuroprotección en recuperación de anestesia donde se inició suspensión de sedación para inicio de despertar con TC post pabellón el 01/09 a las 11:20 sin cambios con respecto al inicial. Se realizó TC Cerebro control el 05.08, que impresionó tamaño ventricular similar al TC del 01.08, con lesiones hemorrágicas similares, evolucionando con obstrucción de DVE, ya permeabilizado por neurocirugía. Se decidió traslado a UPC el 05/08/2022.

Diagnósticos de Ingreso UPC

1. ACV Hemorrágico
- 1.1 Hemorragia Intraventricular (HSA Fisher IV)
- 1.2 Enfermedad de moyamoya bilateral por angiografía.
- 1.3 Hidrocefalia secundaria
- 1.4 DVE (01/08/22 4-5 am)
2. Neumonía Aspirativa
3. Obesidad

Evolución en UPC:

Hemodinámico:

Paciente con hemodinamia estable durante estadía en UPC. Dentro de estudio se pesquisó TEP masivo, iniciándose HNF en BIC, sin compromiso hemodinámico.

Respiratorio:

Paciente ingresó a UPC con VMI protectora, asociada a neumopatía aspirativa en tratamiento antibiótico. Durante evolución se solicitó AngioTC de tórax en contexto de estudio de moyamoya, que evidenció extenso tromboembolismo pulmonar lobar, segmentario y subsegmentario bilateral, sin signos tomográficos que sugieran la presencia de sobrecarga de cavidades cardíacas derechas al momento del estudio. A la ecoscopia con dudosos signos de sobrecarga de VD y con sospecha de TVP a derecha a nivel safeno-femoral y poplíteo. No se realizó ecodoppler de extremidades inferiores, sin embargo, fue evaluada por cirugía vascular quienes refieren no tener indicación de FVC. Evaluada por equipo de neurocirugía, que dado riesgo beneficio se estimó que podría iniciar anticoagulación, por lo cual se inició anticoagulación con BIC de HNF el 14/08. Se logró extubación el 23/08, sin complicaciones.

Neurológico:

Paciente hospitalizada por hematoma intraparenquimatoso en cabeza de núcleo caudado derecho, secundario a síndrome de moyamoya. Con ICH 1 por hidrocefalia, se instaló DVE. Inicialmente con sospecha de infección de SNC por fiebre persistente a pesar de tratamiento antibiótico con ampicilina/sulbactam, se inició tratamiento para cobertura de ventriculitis con meropenem y vancomicina en dosis meníngeas, sin embargo, posteriormente se decidió en conjunto con equipo de infectología suspender el 25/08 dado cultivos de LCR negativos.

Paciente evolucionó con disfunción de DVE, con retiro que no fue tolerado el 18/08, razón por la cual se reinstaló DVE el 20/08. Previo a reinstalación de DVE y en contexto de hidrocefalia aguda, paciente con cuadro caracterizado por compromiso de consciencia e hipus, razón por la cual se sospechó de estado epiléptico no convulsivo. Se realizó carga de levetiracetam y posteriormente se realizó EEG con evidenciación disfunción lenta continua generalizada. Se inició el estudio de síndrome de moyamoya con TC de TAP sin evidencia de otras lesiones vasculares.

Infeccioso:

Inicialmente paciente con neumonía aspirativa por SAMS, se inició tratamiento con AMS, completado tras 7 días de tratamiento. Posteriormente con sospecha de sepsis de foco meníngeo (LCR 09/08 con hipoglucorraquia y lactato en LCR aumentado), se cultivó y se inició Meropenem + Vancomicina en dosis meníngeas, que se desescaló a Meropenem dado cultivos negativos, pero fiebre persistente. En contexto de nuevo hit infeccioso, se solicitan cultivos el 16/08 que resultaron negativos. Destacó evolución persistentemente subfebril pese a parámetros inflamatorios bajos (PCR y procalcitonina). En

Fecha Epicrisis : 23/09/2022 18:11

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 23-09-2022 18:11:51

Página 3 de 5

contexto de cambio de DVE se mandó punta a cultivo el 19/08 de resultado negativo, y cultivo de LCR desde nueva DVE de resultado negativo. Evaluada por equipo de infectología, deciden mantener tratamiento antibiótico hasta obtener resultado de LCR negativo (25/08), siendo suspendido ese día.

Paciente se trasladó a UTIN el 25/08, ingresando en regulares condiciones generales.

Evolución en UTIN:

Hemodinámico:

Paciente se mantuvo con hemodinamia estable, sin requerimientos de DVA.

Respiratorio:

Paciente ingresó a unidad anticoagulada con HNF en BIC por TEP, con mal control de TTPA. Por este motivo se realizó traslape a enoxaparina con buena tolerancia. Se realizó ventana de anticoagulación para instalación de DVP el 09/09, sin complicaciones.

Neurológico:

Con hematoma intraparenquimatoso secundario a síndrome de moyamoya, Suzuki 3-4.; con vaciamiento ventricular que requirió DVE, con disfunción posterior y falla de prueba cierre con reinstalación del mismo drenaje. Durante estadía en UTIN cursó con compromiso de consciencia en contexto de cuadro infeccioso. Se realizó mEEG que evidenció ocasional actividad epileptiforme. Inicialmente se inició fenitoína, sin embargo fue discutido con equipo de epilepsia, quienes sugieren suspender PHT por AE secundaria a hit infeccioso. Se instaló DVP de manera exitosa el 09/09/2022, con TC de cerebro de control sin complicaciones.

Dentro de estudio de Sd moyamoya destacó:

- Angiografía cerebral con sd moyamoya bilateral grado 3-4 en escala Suzuki.
- Estudio: FR 10, C3 217 C4 39 IgA 338 IgG 816 IgM 67 ANCA - AntiDNA - ANA - ENA -
- ACL y AB2GP1 negativa.
- Dentro de estudio destaca VDRL reactivo débil. Se toma MHA-tp que resultó NEGATIVO.
- Anticoagulante lúpico para realizar en ambulatorio por anticoagulación.
- VIH NR
- FRCV TG 98 CT 141 LDL86 HDL35 TSH0.92 T4L0.93 HBA1C 5.2%
- RM: control de hidrocefalia con estabilidad de la amplitud ventricular al comparar con estudio de agosto. Oclusión de las arterias carótidas internas, con presencia de colaterales moyamoya que se anastomosan con las arterias cerebrales medias y arterias cerebrales anteriores. Múltiples pequeñas lesiones parenquimatosas supratentoriales bilaterales, de probable origen isquémico.

Infeccioso:

Durante estadía en UTIN paciente cursó con cuadro séptico de origen urinario. Inicialmente se inició cobertura con dosis de penetración meníngea con vancomicina y meropenem, pero se ajustó terapia por cultivos (urocultivo positivo para E coli MS) a amikacina completando un total de 7 días de tratamiento antibiótico el 06/09 con buena respuesta. Sin nuevos procesos infecciosos.

Por evolución favorable, se decidió traslado a unidad de neurologías agudos el 13/09.

Evolución Neurología agudos:

Neurológico:

Paciente ingresó desde UTIN en buenas condiciones generales, sin cefalea, sin deterioro neurológico. En condiciones de continuar con rehabilitación. El 13/09 se pesquisó fluctuación por mayor paresia crural izquierda, se solicitó TC de encéfalo, sin cambios respecto a estudio previo. Se mantuvo hemodinámicamente estable con tendencia a taquicardia leve intermitente, sin deterioro neurológico.

Respecto a rehabilitación, logró los siguientes hitos:

- Fonoaudiología: Disfagia moderada FILS 8. Régimen licuado + líquidos claros con bombilla.
- Kinesiología: Movilidad activa en cama y SBC con máxima asistencia por izquierda

Dado estabilidad clínica, con estudio etiológico amplio realizado, se decidió traslado a HSJM para continuar con proceso de

Fecha Epicrisis : 23/09/2022 18:11

Página 3 de 5

rehabilitación.

Respiratorio

Paciente clínicamente estable, sin disnea ni requerimientos de oxígeno en contexto de TEP multisegmentario, anticoagulado con enoxaparina 60 mg cada 12hrs, con plan de traslape a terapia oral por lo que el 17/09 se realizó TC de cerebro de control, sin cambios respecto a estudio previo, sin transformación hemorrágica, indicándose inicio de acenocumarol el 18/09, con control seriado de INR para alcanzar rango entre 2-3. Ha recibido el siguiente esquema de acenocumarol:

- 18/09: 2 mg de acenocumarol
- 19/09: 2 mg de acenocumarol
- 20/09: 4 mg de acenocumarol, INR 1.24
- 21/09: 4 mg de acenocumarol, INR 1.1
- 22/09: 4 mg de acenocumarol, INR 1.3
- 23/09: 4 mg de acenocumarol, INR 1.7

Infeccioso:

Paciente evolucionó subfebril con temperatura hasta 37.5°C, además con orina inflamatorio (30-40 leucocitos con abundantes bacterias) y elevación de parámetros inflamatorios (PCR 130), por lo cual se inició terapia con amikacina 1gr ev a ajustar según resultado de UC, el cual evidenció crecimiento de E. coli multisensible, por lo que se completó 10 días de tratamiento con amikacina el 22/09, con evolución favorable (último peak subfebril de 37.3° el 20/09) y parámetros inflamatorios a la baja (22/09 con Gb 9100 y PCR 56).

Otros:

Paciente con dificultad para defecar, alcanzando 5 días sin deposiciones, por lo que se inició PEG. Además, se pesquisó LPP sacra grado II, sin signos de infección, por lo que se indicó manejo posicional horario y curaciones avanzadas por enfermería. El 18/09 se indicó sonda Foley para favorecer curación y evitar infección de LPP, con plan de retiro precoz según evolución de LPP, considerando paciente con ITU baja recurrente durante esta hospitalización.

Dada estabilidad clínica, se indica traslado a HSJM (PCR COVID-19 pretraslado 21/09: negativa)

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular hemorrágico - Hemorragia Cabeza Caudado Ich 1
Síndrome Moya Moya -
Hidrocefalea -
Crisis Epilépticas Reactivas -
Tromboembolismo Pulmonar -
Infección Urinaria Baja -
Neumonía Aspirativa -
Lesión Por Presión Sacra Grado II -
Anemia en estudio -
Disfagia Severa Fils 3 En Rehabilitación -
Trastorno De La Marcha En Rehabilitación -

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J: NO

Examen neurológico al alta:

- Mental: vigil, conecta con examinador de forma consistente, desorientada en tiempo y espacio, inatenta, no sigue órdenes.
Disartria leve. Impresiona heminegligencia izquierda.
-NC: isocoria, hemianopsia izquierda por amenaza, mirada conjugada central impresiona con OCM normal, PFC izquierda.
Pres bajos no evaluables.

- Motor: Espasticidad en ESI e hipotonía en EII, Hemiparesia M3- braquial izquierda, M2 crural, M3 hemicuerpo derecho.
Reflejo plantar extensor izquierdo y flexor derecho.

- Sensitivo: impresiona conservado, con extensión sensitiva a I°

- Cerebeloso: sin nistagmo, resto no evaluable.

- Marcha no evaluada

NIHSS 14 puntos (0-2-1-0-2-1-0-2-1-0-0-1-1-1)

mRS 5

Fecha Epicrisis : 23/09/2022 18:11

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Plan Post Alta

General

- Levantar asistida por Kinesiología
- SNE y alimentación por fórmula con fresubin a 60cc/hrs + compota almuerzo cena + agua libre por SNE 30cc/hr
- Curación de LPP sacra por enfermería
- Retiro precoz de sonda foley según evolución de LPP
- Continuar Rehabilitación por kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional

Medicamentos:

- Acenocumarol 4mg, dosis según INR, vía SNE
- Enoxaparina 60 mg cada 12 hrs, vía subcutánea
- Atorvastatina 20mg, 1 comprimido al día, vía SNE
- Levetiracetam 500 mg, 3 comprimidos cada 12 hrs, vía SNE
- Omeprazol 20mg, 1 comprimido al día, vía SNE
- PEG 17 gramos en 200cc agua cada 8 hrs, vía SNE

Controles:

- Control CDT, pasillo 9, NEUROLOGÍA con Dr. Andrés Silva.
- Control en CDT pasillo 9 con Neurocirugía
- Control en CESFAM en programa cardiovascular y entrega de medicamentos
- Acudir a servicio de urgencia en caso de signos de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Marianela Morales Leal
Becado/Residente



Amada Marcela Espinosa Maramba
Médico Tratante (Staff)